

II. U TR T NG HUY T ÁP VÀ CÁC B NH NG M C TH NG G P

1. I C NG

T ng huy t áp (THA) là b nh tim m ch ph bi n nh t hi n nay, nh h ng n h n 25% dân s tr ng thành t i Vi t Nam. B nh c nh ngh a khi huy t áp tâm thu ≥ 140 mmHg và/hoặc huy t áp tâm tr ng ≥ 90 mmHg.

2. TRI U CH NG LÂM S ÀNG

B nh nhân t ng huy t áp th ng có các tri u ch ng sau:

- au u, c bi t vùng ch m, th ng xu t hi n bu i sáng
- Chóng m t, ù tai
- Khó th khi g ng s c
- au t c ng c
- M m t thoáng qua
- H i h p ánh tr ng ng c

3. CH N OÁN

Ch n oán t ng huy t áp d a trên o huy t áp nhi u l n t i phòng khám hoặc theo dõi huy t áp 24 gi (Holter huy t áp). C n phân bi t v i t ng huy t áp áo choàng tr ng.

Các xét nghi m c n thi t:

- i n tâm (ECG)
- Siêu âm tim
- Ch p X-quang ng c
- Xét nghi m máu: creatinine, glucose, kali, natri

4. II U TR B NG THU C

4.1. Nhóm c ch men chuy n (ACEI)

Enalapril là thu c c ch men chuy n c s d ng r ng rãi trong i u tr t ng huy t áp và suy tim. Li u thông th ng 5-20 mg/ngày. Thu c có th gây ho khan do tích l y bradykinin.

Perindopril c ch nh trong t ng huy t áp, b nh ng m ch vành n nh và suy tim. Li u 4-8 mg/ngày.

Ramipril c bi t có i cho b nh nhân sau nh i máu c tim và ái tháo ng có protein ni u.

4.2. Nhóm chẹn thụ thể angiotensin II (ARB)

Losartan được chỉ định trong tăng huyết áp, được biết đến bệnh nhân không dung nạp ACEI do ho khan. Liều 50-100 mg/ngày.

Valsartan có hiệu quả trong liều từ tăng huyết áp và suy tim. Liều 80-320 mg/ngày.

4.3. Nhóm chẹn kênh canxi

Amlodipine là thuốc chẹn kênh canxi dihydropyridine tác dụng kéo dài, được dùng trong tăng huyết áp và đau thắt ngực ổn định. Liều 5-10 mg/ngày.

Nifedipine có tác dụng phóng thích chậm được dùng trong tăng huyết áp và đau thắt ngực. Thuốc gây phù mắt cá chân, đau bụng.

4.4. Nhóm lợi tiểu thiazide

Hydrochlorothiazide (HCTZ) là lựa chọn đầu tay trong tăng huyết áp không biến chứng. Liều 12.5-25 mg/ngày. Có thể gây hạ kali máu.

Indapamide ít ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose và lipid hơn HCTZ.

4.5. Nhóm chẹn beta

Metoprolol được chỉ định trong tăng huyết áp kèm bệnh mạch vành hoặc rối loạn nhịp tim. Liều 25-200 mg/ngày.

Bisoprolol có tính chọn lọc beta-1 cao, dùng trong tăng huyết áp và suy tim. Liều 2.5-10 mg/ngày.

5. CÁC BỆNH ĐỒNG MẮC VÀ XỬ TRÍ

5.1. Tăng huyết áp và đái tháo đường type 2

Đái tháo đường type 2 thường đi kèm với tăng huyết áp. Liều từ đầu tiên ACEI hoặc ARB để bảo vệ thận. Mục tiêu huyết áp < 130/80 mmHg.

Metformin là thuốc hạ đường huyết đầu tay trong đái tháo đường type 2. Insulin có thể cần thiết khi đường huyết không kiểm soát được bằng thuốc uống.

5.2. Tăng huyết áp và rối loạn lipid máu

Rối loạn lipid máu thường đi kèm với tăng huyết áp. Atorvastatin và Rosuvastatin là các statin thường dùng để điều trị tăng cholesterol LDL.

5.3. Bệnh chuyển thận mạn tính

Tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn tính. Bệnh thận mạn biểu hiện bằng protein niệu, tăng creatinine máu, phù, thiếu máu.

6. PHÁC KẾ THU TRỊ KHÔNG DÙNG THUỐC

- Giảm cân nếu thừa cân (BMI > 23)
- Chế độ ăn DASH: tăng rau quả, giảm muối natri < 6g/ngày
- Hạn chế rượu bia
- Tập thể dục aerobic 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần
- Bỏ thuốc lá

7. CHƯNG CHÁNH

Enalapril và các ACEI chống chỉ định trong thai kỳ (có thể gây quái thai), hẹp động mạch thận hai bên, và thận suy phù mức.

Metoprolol chống chỉ định trong nhồi máu tim chẹn nặng, block nhĩ thất độ cao, và hen phế quản nặng.

Hydrochlorothiazide chống chỉ định trong suy thận nặng và gout cấp.